Suivi du cancer différencié de la thyroïde

À RETENIR

- Objectifs : dépistage précoce des récidives, PEC précoce ; suivi maintenu **à vie**.
- Moyens : clinique, **Tg + anticorps anti-Tg** (en regard de la TSH), échographie cervicale, scintigraphie ^{131}I, TEP FDG.
- Très faible risque sans irathérapie : Tg sous traitement + échographie ; stimulation de la TSH non recommandée.
- Après irathérapie : contrôle à **3 mois** (clinique, TSH, Tg, anti-Tg, adaptation LT4), puis à **6–12 mois** (Tg stimulée + échographie).
- Tg stimulée intermédiaire : **1–10 ng/mL** (sevrage) ou **1–5 ng/mL** (TSH rh) → refaire à 1 an ; ⊕ si > **10** / > **5 ng/mL** → recherche du foyer.
- Tg > **1 ng/mL** sous traitement (dosages consécutifs) → recherche des foyers tumoraux.
- Anticorps anti-Tg ⊕ : Tg non interprétable → suivi par BDT, échographie et cinétique des anti-Tg ; leur disparition = preuve de rémission.

I. Objectifs

- Dépistage précoce des récidives.
- Prise en charge précoce, avec amélioration du pronostic.

II. Moyens de surveillance

- Clinique.
- (1) **Biologique** : dosage de la Tg et des anticorps anti-Tg, en regard de la TSH (degré de freinage).
- (2) Échographie cervicale.
- (3) Scintigraphie à l'^{131}I.
- (4) TEP FDG.

Schéma récapitulatif des notes (p. 19) — la PEC du CDT est multidisciplinaire ⇒ suivi :

Clinique	Biologique	Fonctionnel	Morphologique
Signes fonctionnels (douleur, dyspnée) ; palpation ; inspection	TSH ; Tg ; ATg — sous traitement ou en défreination	BPT ; BDT ; TEP FDG	Échographie ⇒ cytoponction, Tg in situ ; radiographie ⇒ thorax, os… ; TDM, IRM si Tg ↑ ou M+

NB ! — Rechercher : récidive ; résidu ; M+.

III. Déroulement du suivi

1. Suivi à court terme

Patient traité par thyroïdectomie totale sans irathérapie (= patient à très faible risque)

- La surveillance repose sur le dosage de la Tg sérique sous traitement + échographie cervicale.
- La stimulation de la TSH n'est plus recommandée.

Patient traité par thyroïdectomie totale + irathérapie

- Si **BPT** ⊖ : pas de fixation en dehors du lit thyroïdien.
- **Contrôle à 3 mois** : examen clinique ; dosage TSH, Tg, anti-Tg ; adaptation de l'hormonothérapie.
- **Contrôle à 6–12 mois** : examen clinique ; vérifier le bilan thyroïdien sous traitement et l'échographie cervicale ± « EAP » et « Tx » si ⊖ (abréviations non développées dans les notes) ; Tg sous stimulation (β-hCG).

- Si Tg stimulée ⊖ et échographie ⊖ → **suivi annuel**.
- Si Tg stimulée intermédiaire (**1–10 ng/mL** si sevrage ; **1–5 ng/mL** si TSH rh) → refaire une Tg stimulée après **1 an** + surveillance : si indétectable → rémission, suivi annuel ; si Tg ↑ → exploration + traitement.
- Si Tg stimulée ⊕ (> **10 ng/mL** sous sevrage ; > **5 ng/mL** sous TSH rh) → exploration = recherche du foyer de récidive + traitement.
- Si échographie ⊕ : échographie de contrôle à **3 mois / 6 mois** d'intervalle ; si persistance de l'anomalie ou ↑ de taille… : cytoponction ± Tg in situ dans le liquide de rinçage (**1 cc** de SSI → tube sec).

- Si **Tg > 1 ng/mL sous traitement**, vérifiée sur des dosages consécutifs : recherche des foyers tumoraux en cause (échographie, TDM CTAP, scintigraphie osseuse, TEP…), puis traitement.
- Si **anticorps anti-Tg ⊕** :
  - le taux de Tg sérique n'est plus un paramètre de suivi dans ce cas ;
  - surveillance par BDT et échographie + cinétique des anticorps anti-Tg ;
  - la disparition des anticorps anti-Tg est considérée comme une preuve de rémission.

2. Suivi à long terme

- Le suivi est maintenu **à vie**.
- Suivi annuel (examen clinique, bilan thyroïdien, échographie cervicale).
- Échographie non systématique si faible risque + Tg ⊖ ; tous les **1–3 ans** si haut risque.
- Réajustement de l'hormonothérapie selon le risque initial et la tolérance au traitement.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Que comporte le contrôle à 3 mois après irathérapie ?	Examen clinique, dosage TSH, Tg, anti-Tg, adaptation de l'hormonothérapie.
2. Seuils d'une Tg stimulée « intermédiaire » ?	1–10 ng/mL sous sevrage ; 1–5 ng/mL sous TSH rh.
3. Conduite si Tg stimulée ⊖ et échographie ⊖ ?	Suivi annuel.
4. Que faire si les anticorps anti-Tg sont positifs ?	La Tg n'est plus un paramètre de suivi : BDT + échographie + cinétique des anti-Tg.
5. Rythme de l'échographie au long cours chez un patient à haut risque ?	Tous les 1 à 3 ans (non systématique si faible risque et Tg ⊖).